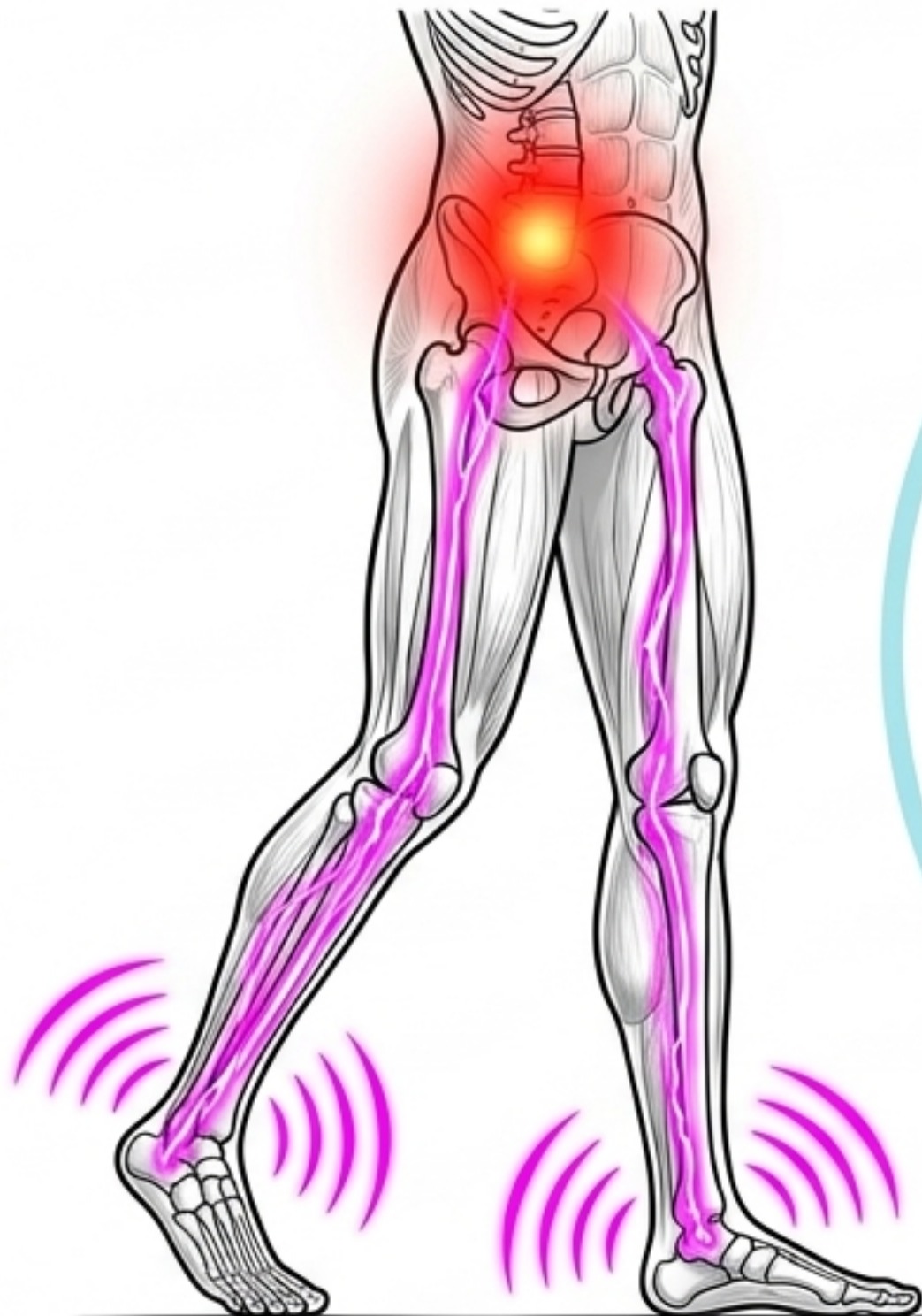


CIRUGÍA GENERAL Y GASTROENTEROLOGÍA

REPASO ESTRUCTURADO DE ALTO RENDIMIENTO

Semiología Quirúrgica: El Signo de Infante Díaz



¿Qué es?

Maniobra semiológica de transmisión de vibración (conocida internacionalmente como Heel-drop test o Signo de Markle).

Mecanismo

Impacto de talones → Transmisión de vibración → Movilización de peritoneo inflamado → Dolor.

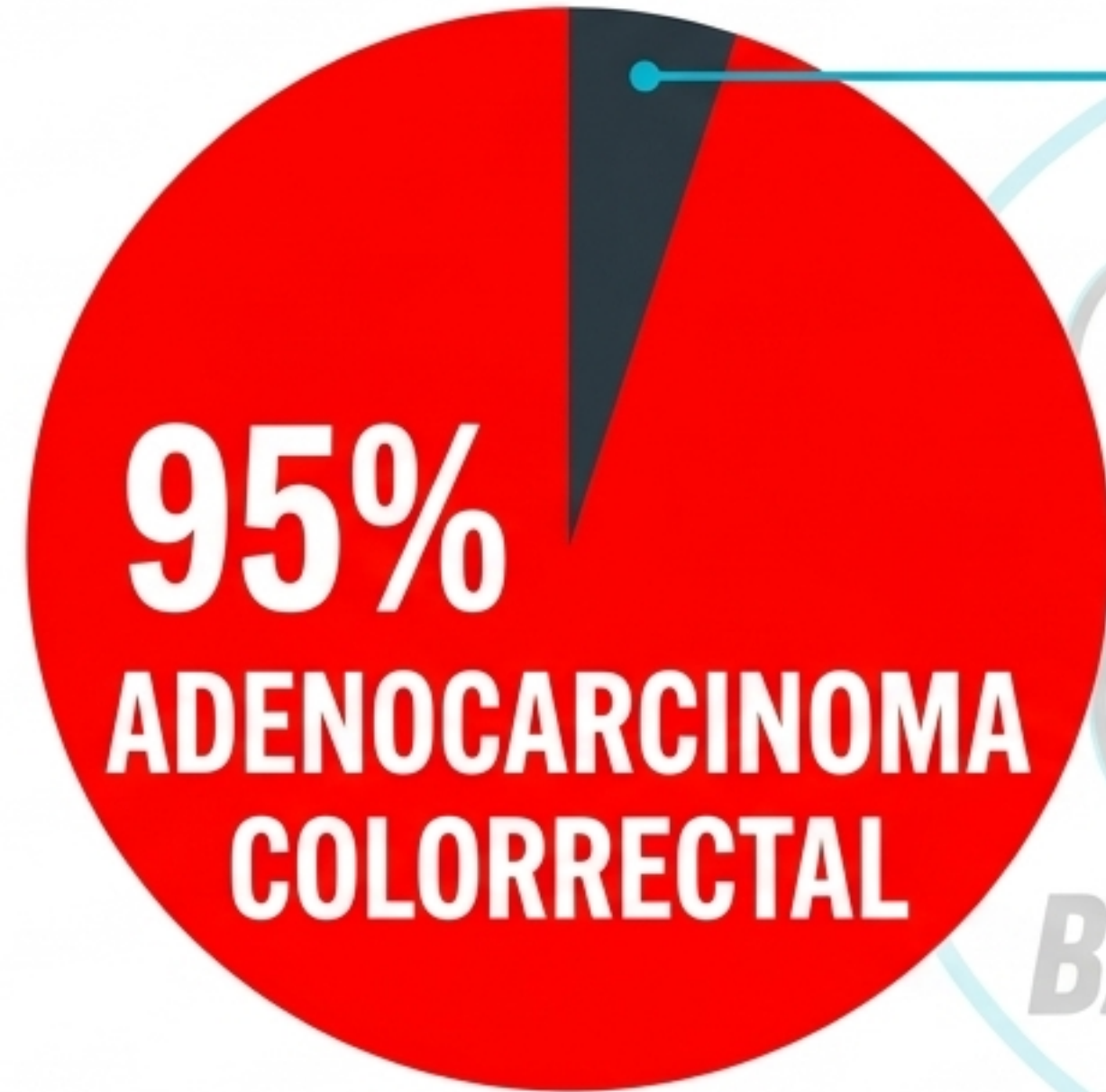
Dato Fijo ⚠

Es un signo indirecto de irritación peritoneal. Si duele en la Fosa Ilíaca Derecha (FID), apoya el diagnóstico de apendicitis, pero no es patognomónico.

Matriz Diagnóstica: Signos de Irritación Peritoneal

MANIOBRA	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO
Blumberg	Dolor a la descompresión brusca de la pared abdominal.
Markle / "Infante Díaz"	Dolor por transmisión de vibración al caer sobre los talones.
Talopercusión	Dolor generado por la percusión directa del talón con la pierna extendida.
Rovsing	Presión sostenida en fosa ilíaca izquierda provoca dolor en la fosa ilíaca derecha (desplazamiento de gas).
Psoas	Dolor por irritación del músculo psoas al realizar extensión pasiva de la cadera derecha.
Obturador	Dolor por irritación del músculo obturador interno al realizar rotación interna del muslo flexionado.

“Nombre y Apellido” de las Neoplasias de Colon



El 5% Restante

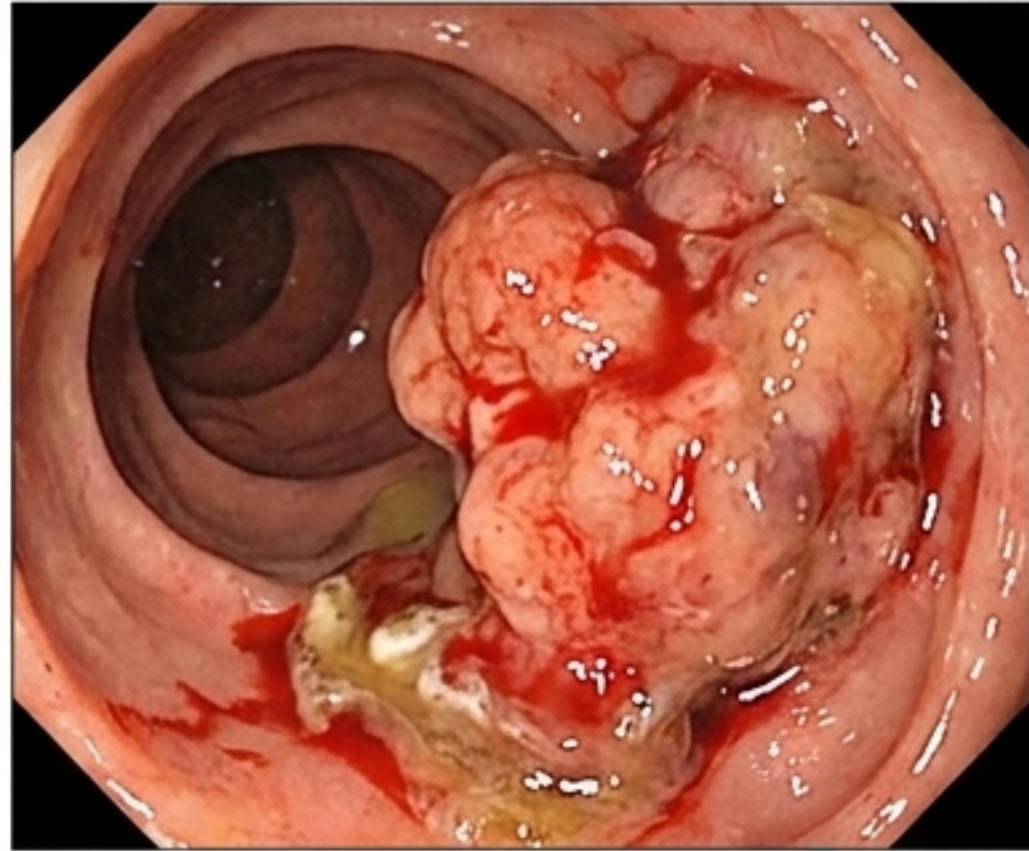
- Epiteliales: Mucinoso, Células en anillo de sello, Medular, Micropapilar, Serrado, Adenoescamoso.
- No Epiteliales: Neuroendocrinos, Linfoma, GIST, Leiomioma, Metástasis.



EL REY ABSOLUTO: Cuando escuches “tumor de colon” en un examen, el diagnóstico por defecto es siempre **ADENOCARCINOMA COLORRECTAL**.

Dualidad Clínica: Colon Derecho vs. Colon Izquierdo

COLON DERECHO



- **Fisiología:** Mayor diámetro, contenido líquido.
- **Morfología:** Lesiones exofíticas, polipoideas, voluminosas.
- **Clínica Típica:** **Sangrado oculto crónico → Anemia ferropénica.** (Cansancio, pérdida de peso, masa palpable). ¡Tarda más en obstruir!

COLON IZQUIERDO



- **Fisiología:** Menor diámetro, heces sólidas.
- **Morfología:** Crecimiento anular, estenosante (Lesión en 'Servilletero').
- **Clínica Típica:** **Cambio de hábito intestinal → Obstrucción temprana.** (Disminución del calibre fecal, estreñimiento, hematoquecia).

Mapeo Clínico por Segmentos

TRANSVERSO

Dolor abdominal, anemia, pérdida de peso, obstrucción. Manejo quirúrgico adaptado estrictamente al territorio linfovascular.

SIGMOIDES

Estreñimiento progresivo, alteración del calibre fecal, rectorragia/hematoquecia, tenesmo distal.

RECTO

Rectorragia, tenesmo constante, sensación de evacuación incompleta, secreción mucosa.

ALERTA ROJA (Dato Fijo): Cáncer de Colon ≠ Cáncer de Recto. La estrategia diagnóstica y terapéutica cambia de forma fundamental.



Principios Quirúrgicos Oncológicos

**[Tumor] + [Colon] + [Mesocolon] + [Pedículos Vasculares] +
+ [Ganglios Linfoides] = RESECCIÓN ONCOLÓGICA**

Regla de Oro:

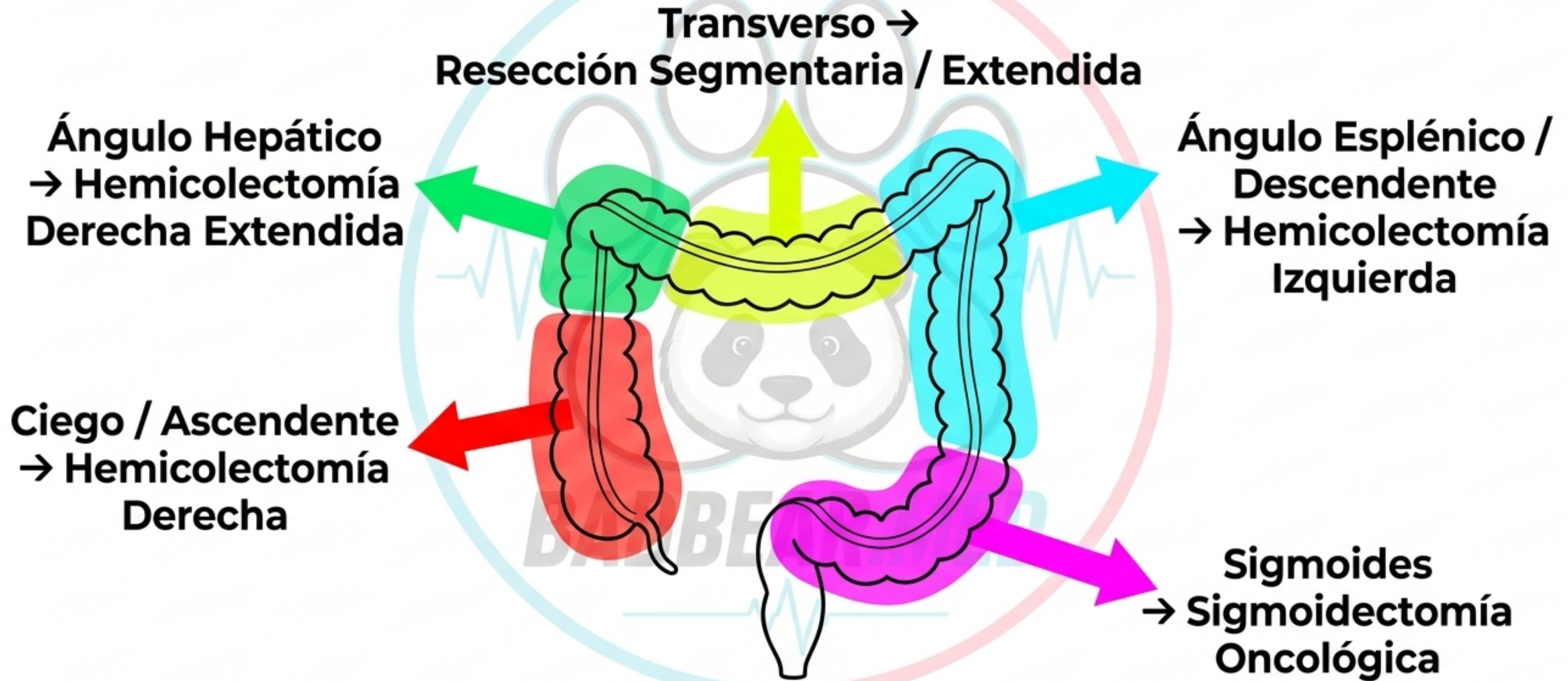
No se retira solamente el tumor. La resección quirúrgica debe seguir estrictamente el **territorio de drenaje linfovascular** del segmento colónico afectado para ser considerada curativa.



Estándar de Calidad (Dato Fijo):

Se deben evaluar idealmente **≥12 GANGLIOS LINFÁTICOS** en la pieza quirúrgica para garantizar una correcta estadificación ganglionar (N).

Mapa de Colectomías Oncológicas



El Paradigma del Cáncer de Recto



cm desde el
margen anal

El Cambio de Lógica:

El abordaje quirúrgico depende milimétricamente de la altura del tumor, su relación con los esfínteres, la fascia mesorrectal y el estadio (T/N).

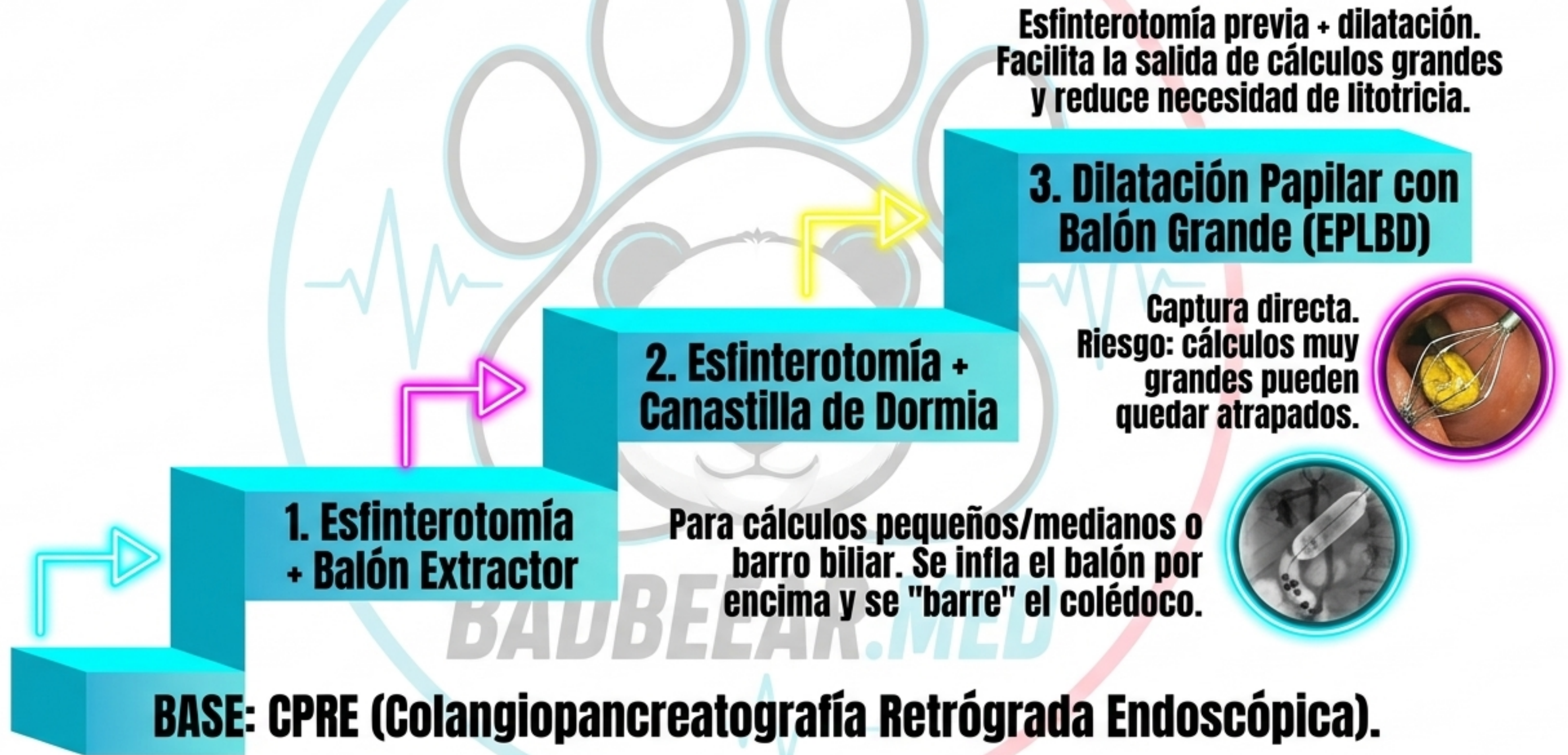
Arsenal Quirúrgico:

- Resección anterior
- Resección anterior baja
- Amputación abdominoperineal (APR)

Dato Fijo Vital:

A diferencia del colon, el cáncer rectal localmente avanzado exige Quimioterapia + Quimioterapia + Radioterapia (o Terapia Neoadyuvante Total - TNT) ANTES de operar.

Vía Biliar: Escalera Terapéutica CPRE (Parte 1)



Vía Biliar: Técnicas Avanzadas CPRE (Parte 2)

Si no se extrae hoy, se drena la vía biliar y se programa segunda sesión. El roce del stent ayuda a fragmentar.

Fragmentación con láser para cálculos impactados o extremadamente difíciles.

7. Stent Biliar Temporal (Terapia Puente)



6. Litotricia Láser



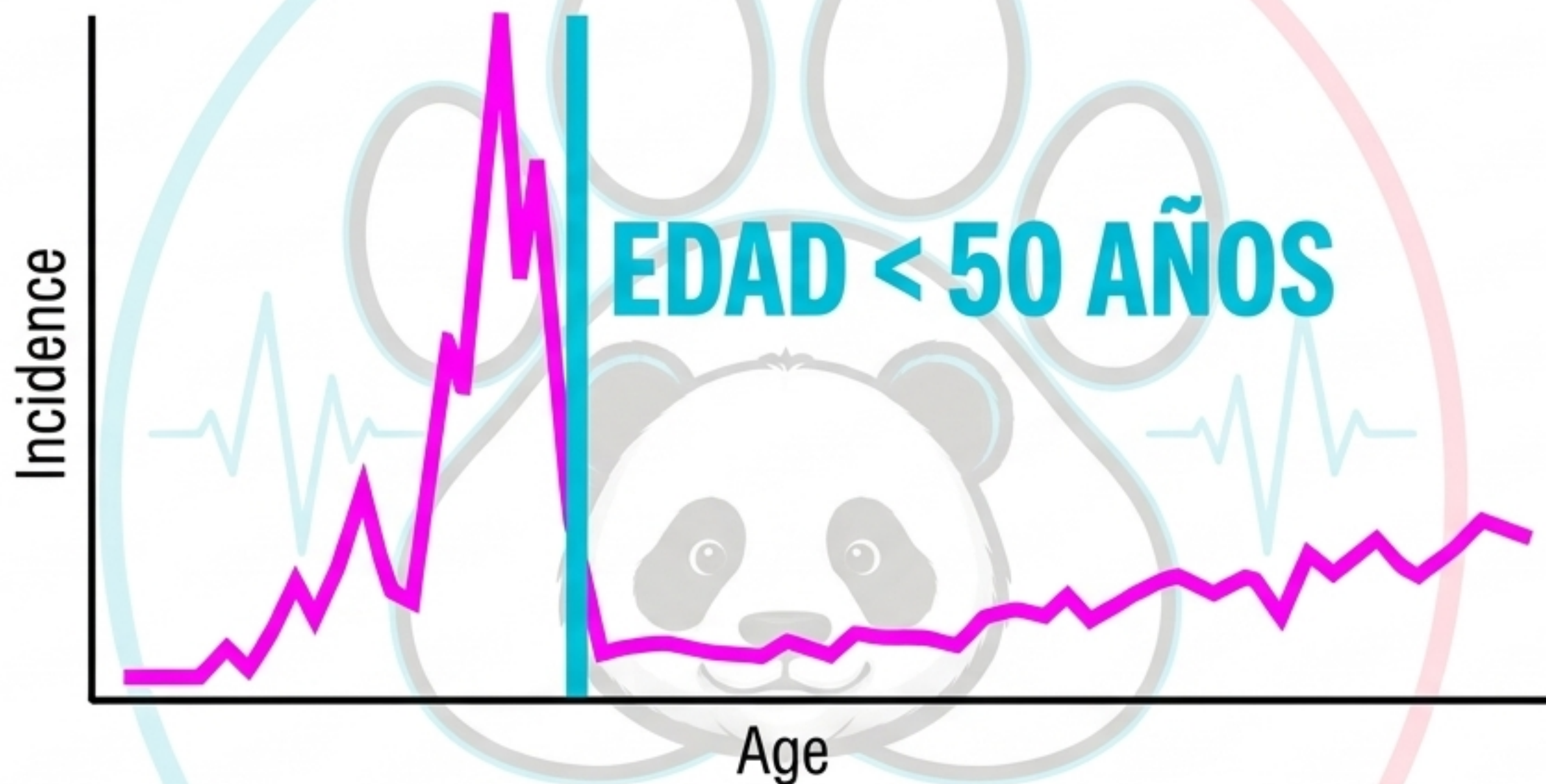
Ondas de choque bajo visión directa mediante colangioscopia.

5. Litotricia Electrohidráulica (EHL)

Fragmentación física con litotriptor cuando el cálculo no pasa.

4. Litotricia Mecánica

Nueva Epidemia: Cáncer Colorrectal de Aparición Temprana



Definición:

Cáncer colorrectal diagnosticado antes de los 50 años.



El Fenómeno:

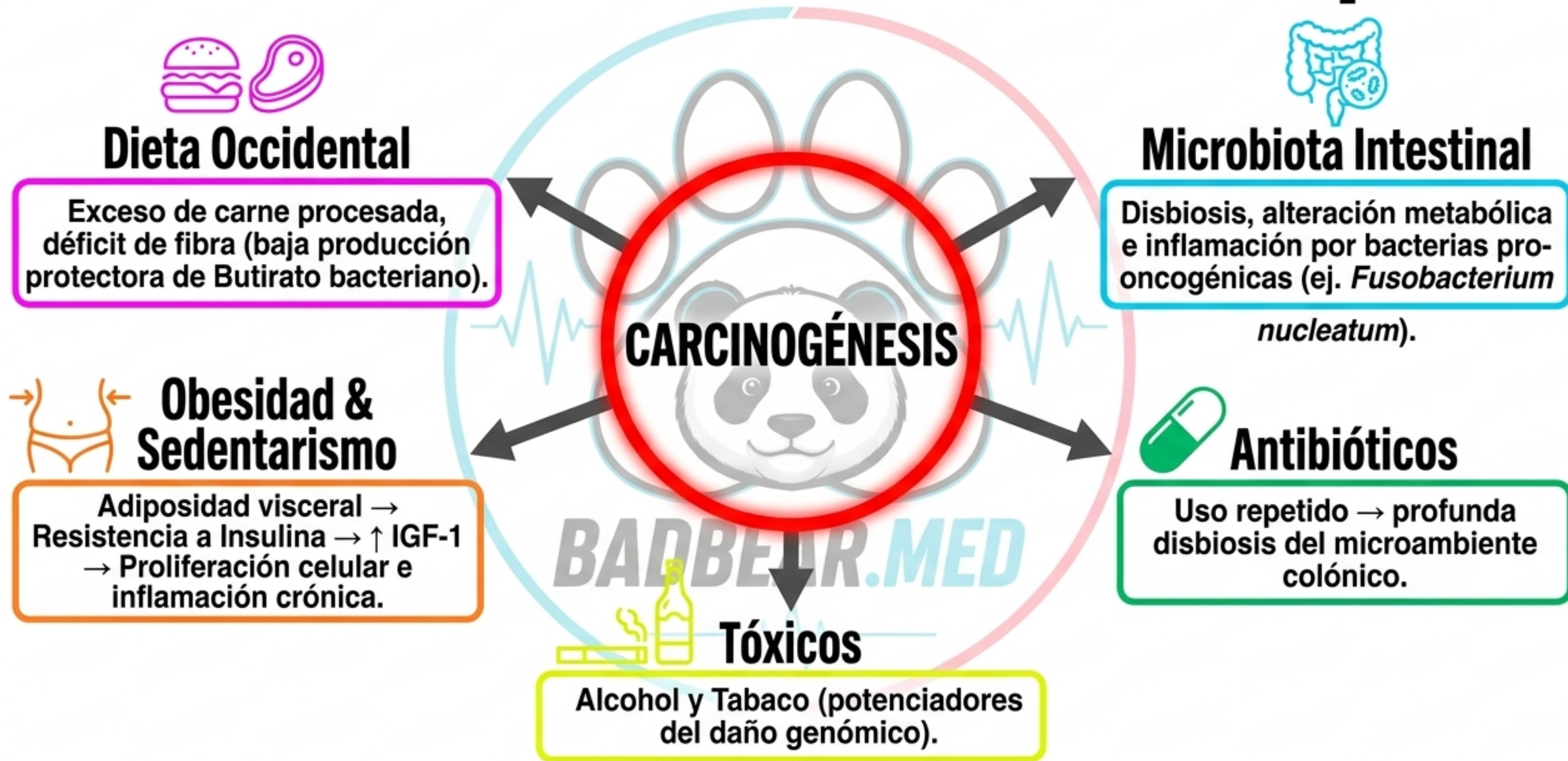
Mientras la incidencia baja en adultos mayores (gracias al tamizaje), se dispara globalmente en jóvenes de forma alarmante.



Dato Fijo:

La etiología es estrictamente multifactorial. No existe un solo factor culpable aislado demostrado.

Red de Causalidad del Cáncer Temprano



La Secuencia Clásica: Inestabilidad Cromosómica

Epitelio
Normal

Adenoma
Temprano

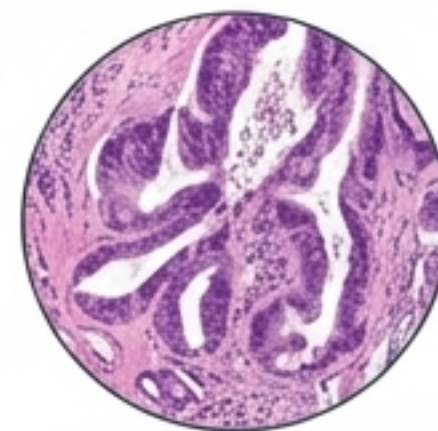
Adenoma
Avanzado

Adenocarcinoma
Colorrectal

Mutación APC
(Pérdida de gen
supresor)

Mutación KRAS
(Activación de
Oncogén)

Mutación TP53
(Pérdida de guardián
genómico)



Nota: Esta es la **vía esporádica clásica**. Existen vías alternas (**MSI, Serrada**) y herencias (**Lynch, PAF**), pero la mayoría de los cánceres tempranos actuales son de origen esporádico.

BADBEAR.MED FIJA: Check-List Quirúrgico

- ✓ **Infante Díaz / Markle:** Signo indirecto de irritación peritoneal (talopercusión vibratoria).
- ✓ **Rey de las Neoplasias:** El Adenocarcinoma domina todos los segmentos del colon.
- ✓ **Dualidad:** Colon Derecho = Anemia / Exofítico. Colon Izquierdo = Obstrucción / Servilletero.
- ✓ **Linfadenectomía:** Resección oncológica exige un mínimo de ≥ 12 ganglios para estadificación N.
- ✓ **Algoritmo Biliar:** Cálculo simple (Balón/Dormia) → Cálculo grande (EPLBD) → Cálculo difícil (Colangio + EHL/Láser) → Falla (Stent puente).
- ✓ **Epidemia <50 Años:** Aumento global es estrictamente multifactorial (Obesidad, disbiosis, insulina, dieta). Nunca culpar a un solo factor aislado.